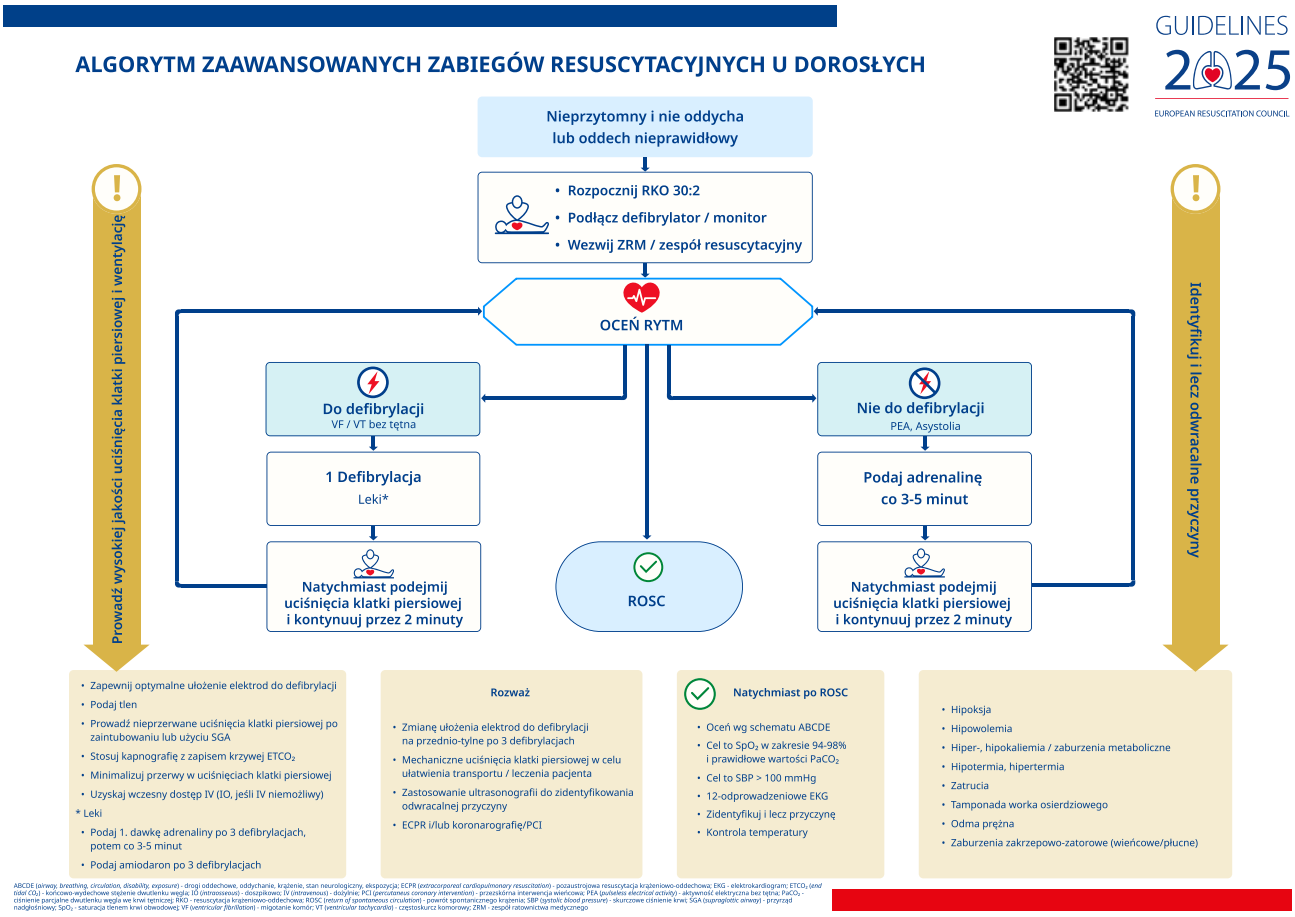
- Identyfikacja osób z chorobami dziedzicznymi oraz badania przesiewowe członków ich rodzin mogą zapobiec zgonom wśród młodych osób z dziedzicznymi schorzeniami serca.
- Należy stosować aktualne wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia omdleń oraz zaburzeń rytmu serca.

Leczenie IHCA

- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne należy rozpocząć jak najwcześniej.
- Celem leczenia w szpitalnej opiece systemowej powinno być szybkie rozpoznanie zatrzymania krążenia, natychmiastowe rozpoczęcie RKO, szybka defibrylacja (w czasie < 3 min) w przypadku rytmów do defibrylacji, szybkie podanie adrenaliny w rytmach nie do defibrylacji oraz identyfikacja i leczenie odwracalnych przyczyn.
- Wszyscy pracownicy szpitala powinni potrafić szybko rozpoznać zatrzymanie krążenia, wezwać pomoc, rozpocząć RKO oraz przeprowadzić defibrylację (podłączyć AED i postępować według jego wskazań lub użyć defibrylatora manualnego).
- Szpitale powinny przyjąć ujednolicony numer telefonu (2222) do zgłaszania zatrzymania krążenia (*cardiac arrest call*).
- W szpitalach powinny być zespoły resuscytacyjne, które natychmiast reagują na IHCA.
- Szpitalny zespół resuscytacyjny powinien się składać z osób, które ukończyły certyfikowany kurs ALS u dorosłych, obejmujący szkolenie z pracy zespołowej i kierowania zespołem.
- Członkowie zespołu resuscytacyjnego powinni posiadać kluczowe umiejętności i wiedzę z zakresu postępowania w zatrzymaniu krążenia, w tym umiejętność manualnej defibrylacji, zaawansowanego zabezpieczania drożności dróg oddechowych, uzyskiwania dostępu dożylnego i doszpikowego oraz identyfikacji i leczenia odwracalnych przyczyn.
- Zespół resuscytacyjny powinien się spotykać na początku każdej zmiany w celu przedstawienia się i przydzielenia ról jego poszczególnym członkom.
- Należy standaryzować sprzęt do resuscytacji w szpitalach.
- Zasady kończenia resuscytacji (TOR) nie powinny być wykorzystywane jako jedyna strategia podejmowania decyzji o zakończeniu resuscytacji wewnątrzszpitalnej.

Leczenie OHCA

- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne należy rozpocząć tak wcześnie, jak to możliwe – systemy ratownictwa medycznego powinny być zorganizowane w sposób umożliwiający szybkie wdrożenie ALS przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Może to obejmować zespoły intensywnej opieki przedszpitalnej



Rycina 11. Algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych